

Litiasis biliar

Bibliográfica 2019 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David

Consenso AEP

PRONAP 2017 Módulo 1

Existencia de cálculos en la luz de las vías biliares.

Incidencia: 0,15% a 0,22%, con un importante aumento en la pubertad.

En los niños el 75% de los cálculos son de pigmento.

Composición de los cálculos

1.a- Cálculos pigmentarios negros

Contienen cristales de bilirrubinato cálcico, fosfato y carbonato cálcicos y <10% de colesterol.

Son cálculos múltiples, pequeños, de color negro, consistencia dura y superficie irregular.

El 50% de ellos son radiopacos.

Por aumento de la concentración de bilirrubina no conjugada

1.b- Cálculos pigmentarios pardos

Suelen ser múltiples, redondeados,

Contienen hasta un 30% de colesterol y el resto sales cálcicas de bilirrubina no conjugada

Suelen ser radiolúcidos

Pueden formarse en la vesícula o en los conductos biliares.

Los principales factores patogénicos son la estasis y la infección biliar.

2. Cálculos de colesterol

Suelen ser radiotransparentes.

Mecanismos patogénicos:

- Bilis sobresaturada de colesterol: por aumento de la secreción de colesterol o una disminución de la secreción de sales biliares
- Nucleación: favorecido por glucoproteínas termolábiles, calcio y estasis vesicular.
- Permanencia, cohesión y crecimiento de los cristales: favorecidos por la hipomotilidad vesicular.

Barro biliar

Es un gel viscoso que contiene mucina, bilirrubinato cálcico y cristales de colesterol.

En ocasiones, el barro puede preceder a la aparición de cálculos macroscópicos. Se asocia con el ayuno y con la nutrición parenteral total, que ocasiona estasis biliar por disminución de la circulación enterohepática y de la función de la colecistoquinina.

Enfermedades asociadas a litiasis biliar infantil

- Enfermedad hemolítica (20 a 30%)
- No hemolíticas (40 a 50%):
 - Obesidad: por sobrecarga de bilis debido al exceso de colesterol. Actualmente es la variedad más común
 - Nutrición parenteral total (la mayoría de estos cálculos desaparece al reiniciar la vía enteral).
 - Ayuno prolongado.
 - Enfermedad de Crohn.
 - Resección ileal.
 - Furosemida.
 - Bypass cardiopulmonar.
 - Malformaciones biliares congénitas.
 - Colestasis intrahepática familiar progresiva (PFIC).
 - Enfermedad hepática crónica.
 - Fibrosis quística páncreas.
 - Anticonceptivos orales / Embarazo

- Ceftriaxona: Se le conoce como pseudolitiasis por ser un fenómeno transitorio; los litos se disuelven en promedio 15 días después de suspender el medicamento.
- En el 30 a 40% de los pacientes, la litiasis se considera idiopática al no tener factores de riesgo ni enfermedades asociadas.

Manifestaciones clínicas

1. Niños menores de 2 años (10%)

Pueden ser:

- Asintomáticos o
- Presentar ictericia, acolia transitoria, dolor abdominal y sepsis.

2. 2 y 14 años (40%)

Pueden presentar:

- Síntomas biliares típicos 40 a 50%: dolor en cuadrante superior derecho o epigástrico con o sin náuseas, vómitos e intolerancia a las grasas.
- Dolor abdominal no específico 20 a 30%.
- Abdomen agudo 5 a 10%, debido a colecistitis aguda, pancreatitis o colangitis.
- Asintomático 20%.

3. Adolescentes entre 14 y 18 años (50%)

Dolor en cuadrante superior derecho e intolerancia a las grasas.

En los pacientes con enfermedades hemolíticas puede presentarse como dolor abdominal difícil de diferenciar del dolor ocasionado por crisis de hemólisis. Siempre que exista hemólisis es importante buscar la presencia de litos en la vesícula biliar.

Diagnóstico

- Ecografía: método diagnóstico de elección. Los cálculos se ven como imágenes hiperecogénicas con sombra posterior, a diferencia del barro biliar, en el que se observan ecos de baja amplitud sin sombra posterior.
- Radiografía simple de abdomen. Tiene baja sensibilidad porque sólo detecta los cálculos radiopacos.
- Gammagrafía con HIDA-99Tc. Puede estar indicada para el diagnóstico de colecistitis o anomalías de la vía biliar asociadas a los cálculos.
- Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Puede ser útil en el diagnóstico de la coledocolitiasis (donde la ecografía es poco sensible). En algunos casos se puede extraer el cálculo por papilotomía endoscópica, pero la experiencia en los niños es escasa.

Tratamiento

Actitud expectante

En los pacientes asintomáticos o con síntomas inespecíficos como dispepsia o intolerancia grasa.

— Se ha comprobado la desaparición espontánea de los cálculos biliares en la infancia, sobre todo en los niños más pequeños.

— Sólo un 18% de los pacientes con litiasis asintomática desarrollan síntomas biliares o complicaciones a los 15 años de evolución.

Cuando aparecen complicaciones, éstas suelen ser precedidas de cólico biliar, es decir, las litiasis asintomáticas suelen hacerse sintomáticas antes de dar complicaciones.

Tratamientos no quirúrgicos

— Ácido ursodeoxicólico. Disuelve los cálculos de colesterol cuando éstos son de pequeño tamaño. Para su uso se requiere que el cálculo sea radiotransparente, menor de 5 mm y que la vesícula sea funcional. En estos casos se consigue la disolución del cálculo en el 50-60% de los pacientes. Se requiere un tratamiento prolongado (si en 6 meses no hay respuesta debe suspenderse). El riesgo al suspenderlo es la recidiva que se calcula del 10% al año y en la mayoría se va a producir entre los 3 y los 20 años.

— Litotricia extracorpórea. Consiste en la fragmentación de los cálculos por ondas de choque para facilitar su disolución. Se tiene que asociar siempre un tratamiento con ácido ursodeoxicólico por vía oral.

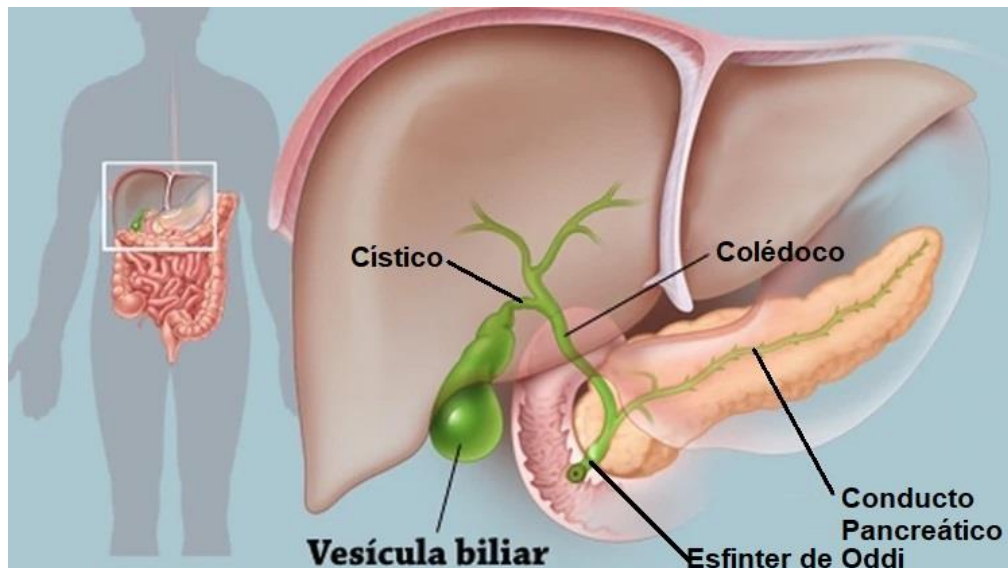
Colecistectomía laparoscópica

Indicaciones:

1. Pacientes de cualquier edad con sintomatología clara de colecistitis por litiasis: ictericia, fiebre y dolor en hipocondrio derecho, tríada clásica de esta enfermedad que se suele acompañar de vómitos y mal estado general. Debe elegirse el momento más oportuno para la intervención, una vez resuelto el cuadro agudo con ayuno y antibióticos.
2. No se recomienda la cirugía en niños menores de 4 a 5 años asintomáticos o con síntomas inespecíficos.
3. Luego de los 4 a 5 años los niños con la escolaridad cambian su alimentación, aumentan el ejercicio físico y pueden pasar de asintomáticos a sintomáticos. Pueden presentar síntomas larvados, como dolor abdominal recurrente, vómitos injustificados, dispepsia u otros inespecíficos, en estos casos si se demuestra la existencia de cálculos radiopacos puede estar indicada la intervención quirúrgica.

Complicaciones de la litiasis biliar

Son poco frecuentes. Se deben a obstrucción de los flujos biliar o pancreático. Incluyen obstrucción del conducto biliar común, colecistitis acalculosa y pancreatitis aguda, esta última se presenta en el 25% de las complicaciones de litiasis vesicular.



Colecistitis

1. Acalculosa infecciosa

Pueden ser el 50% de los casos de colecistitis, antes se relacionaba con pacientes críticamente enfermos, pero actualmente se vio en pacientes con varias enfermedades infecciosas.

Los síntomas son dolor abdominal (de leve a severo) más en cuadrante superior derecho y fiebre, se diagnostica con ecografía porque presenta engrosamiento de la pared mayor a 4,5 mm, pericolecistitis y presencia de barro biliar, la presencia de al menos dos de estos criterios y la ausencia de cálculos hacen el diagnóstico. El riesgo

mayor lo presentan los niños con alimentación parenteral total, ayuno prolongado, narcóticos opiáceos IV, shock, múltiples transfusiones y sepsis.

Las bacterias asociados son: *Salmonella typhi*, *Streptococcus pyogenes*, *Acinetobacter baumannii*, *Streptococcus pneumoniae*, *Staphylococcus epidermidis*, *Burkholderia cepacia* y *Stenotrophomonas maltophilia*. Los virus VHA y VEB.

2. Calculosa

Se define como la inflamación de la vía biliar que se produce por la obstrucción por litiasis, esto edematiza la vesícula por la concentración de ácidos biliares que llevan a isquemia de la pared y a la infección bacteriana. La mayoría de las veces se produce por obstrucción del cístico por un cálculo.

Clínica

- Dolor epigástrico o en cuadrante superior derecho
- Nauseas
- Vómitos
- Fiebre
- Ictericia (20%, pero más frecuente en pediatría que en adultos)

Complementarios

- Radiografía abdominal: solo se observan los cálculos radiopacos.
- Ecografía: es de elección, puede encontrarse engrosamiento de la pared mayor a 4-5 mm, edema (signo de doble pared), barro, líquido pericolecistitis y signo de Murphy ecográfico.
- Analítica
 - Hemograma: habitualmente leucocitosis
 - PCR
 - Función hepática con bilirrubina: aumento de FAL, GGT y BD, cuando es 2° a cálculos pigmentarios predomina el aumento de la BI (por elevada actividad β -glucoronidasa de la bilis infectada).
 - Amilasa: pancreatitis 2° cuando el cálculo impacta desde el esfínter de Oddi a zonas distales.

Tratamiento

- Dieta "0"
- Hidratación EV
- ATB EV
 - Ceftriaxona + metronidazol
 - Ampicilina-sulbactam
 - Piperacilina-tazobactám
 - Ticarcilina-clavulánico

Luego del cuadro agudo:

- Colecistectomía: laparoscópica en general se efectúa de rutina en lactantes sintomáticos y niños con colelitiasis.
- Colangiografía endoscópica retrógrada con extracción de los cálculos es una opción en los niños mayores y adolescentes.

Colangitis aguda

Caracterizada por la presencia de signos y síntomas de infección sistémica, debidos casi siempre a la impactación de un cálculo en el colédoco (90%).

Clínica

Tríada de Charcot

- Ictericia
- Fiebre
- Dolor en HD

Constituye la presentación más típica, no es infrecuente la presencia de colestasis sin ictericia, o de una leucocitosis sin fiebre.

El aumento de la permeabilidad de la membrana hepatocitaria puede explicar una elevación concomitante de GOT y GPT

La asociación de shock sugiere una colangitis supurada grave.

Analítica

Similar a los resultados hallados en la colecistitis y también pueden aumentar la GOT y GPT al afectar el drenaje de los conductos intrahepáticos.

Tratamiento

Similar al de colecistitis con pedido previo al ATB de HMC por 2.

Cólico biliar aislado (sin colecistitis ni colangitis)

Este paciente se presenta afebril

1° solicitar:

- Hemograma
- PCR
- Función hepática con bilirrubina
- Amilasa

Tratamiento

Con hemograma, PCR y amilasa normal se realiza solo tratamiento analgésico con AINEs, preferentemente Dipirone con dosis de carga a 20mg/Kg/dosis.

El uso de Hioscina es controvertido, si se administra no se debe utilizar sin AINEs ya que se ha comprobado que su efecto como analgésico es inferior a estos.